

MEDQUERY AI - MANUAL DE URGENCIAS HOSPITALARIAS

ID Documento: MQ-URG-201

Título: Protocolo de Actuación Inmediata en Ataque Cerebrovascular Isquémico

Diagnóstico Presuntivo: ACV Isquémico Agudo (Código ACV)

Síntomas Guía: Hemiparesia, disartria, asimetría facial, afasia, alteración de la marcha

Especialidad: SPEC_{NEU}

Versión: v2.0 (Agosto 202)

Población Objetivo: Ad

Medical Owner: Jefatura

BLOQUE DE REANIMACIÓN CRÍTICA - TRIAGE: URG L1 RED

Acción de Primera Línea: Activación inmediata del Código ACV al ingreso. Priorizar la estabilización hemodinámica (asegurar vía aérea si Glasgow < 8). Traslado prioritario a Tomografía Computada (TC) de cráneo sin contraste dentro de los primeros 20 minutos desde el arribo para descartar etiología hemorrágica.

Drogas de Elección:

- **Fibrinolítico Mandatorio:** Alteplasa (rtPA) a dosis de 0.9 mg/kg (Dosis máxima absoluta: 90 mg). Administrar el 10 % del total calculado en bolo intravenoso directo durante 1 minuto; el 90 % restante se infunde de forma continua mediante bomba de infusión para un período exacto de 60 minutos.

Alerta de Seguridad / Contraindicación Crítica: No iniciar bajo ninguna circunstancia la infusión de Alteplasa si el tiempo de evolución desde el inicio de los síntomas (tiempo de ventana) es mayor a 4.5 horas, o si la Presión Arterial es $\geq 185/110$ mmHg. En caso de hipertensión severa, se debe estabilizar primero utilizando Labetalol 10 a 20 mg IV antes de proceder con la fibrinólisis. Contraindicado absolutamente ante antecedentes de hemorragia intracraneal previa, diátesis hemorrágica o recuento de plaquetas $< 100,000/\mu L$.

1 Introducción y Justificación del Código

El ataque cerebrovascular (ACV) es una emergencia médica tiempo-dependiente. La ventana de oportunidad terapéutica para la perfusión tisular es estrecha. El objetivo primordial de este manual operativo es coordinar las acciones del equipo de guardia, enfermería y diagnóstico por imágenes para minimizar el tiempo "puerta-aguja", garantizando que el paciente reciba el tratamiento fibrinolítico óptimo para reducir las secuelas neurológicas permanentes.

2 Evaluación Clínica Inicial y Escala NIHSS

El médico de la guardia debe realizar un examen neurológico dirigido empleando la escala NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale). Se consideran signos de alarma inmediatos:

- **Facia:** Caída o debilidad de un lado de la cara (se le pide al paciente que sonría).
- **Miembros:** Pérdida de fuerza en un brazo o pierna (se le pide que mantenga los brazos extendidos).
- **Habla:** Dificultad para articular palabras, lenguaje incoherente o incapacidad para comprender órdenes simples.

Un puntaje NIHSS entre 4 y 25 puntos clasifica al paciente como candidato ideal para la terapia de perfusión farmacológica, siempre que se descarte hemorragia en las imágenes.

3 Flujograma Técnico de Diagnóstico por Imágenes

El diagnóstico definitivo requiere la exclusión de colecciones hemorrágicas mediante neuroimagen:

1. **TC de Cráneo Simple (Sin Contraste):** Es el estudio de primera línea. Su rol principal es descartar hemorragia intracraneal aguda, tumores o malformaciones vasculares. No se debe demorar la terapia esperando signos de infarto establecido en la tomografía.

2. **Evaluación del Score ASPECTS:** En el caso de observar signos tempranos de isquemia en el territorio de la arteria cerebral media, se calculará el puntaje ASPECTS. Un valor inferior a 6 contraindica la fibrinólisis por alto riesgo de transformación hemorrágica.

4 Cuidados Posteriores a la Fibrinólisis y Destino Interno

Finalizada la infusión de Alteplasa, el paciente debe ser derivado de forma obligatoria a la Unidad de Cuidados Intensivos (SPEC-ICU) o Unidad de Stroke para monitoreo continuo durante las siguientes 24 horas:

- Realizar controles de presión arterial cada 15 minutos durante las primeras 2 horas, luego cada 30 minutos por 6 horas, y posteriormente cada hora hasta cumplir las 24 horas. Mantener estrictamente la TA < 180/105 mmHg.
- Reposo absoluto en cama con la cabecera parametrizada a 30 grados.
- Suspender cualquier terapia antitrombótica (Aspirina, Clopidogrel o Heparina) durante las 24 horas posteriores a la infusión del fibrinolítico. Se solicitará una TC de control antes de reiniciar estos fármacos.